

医疗门诊就诊对话模板（真实场景版）

场景：内科门诊，患者因“反复咳嗽、咳痰1周，伴胸闷2天”就诊，医生规范问诊、查体、给出诊疗建议，全程贴合临床真实流程，无虚构医疗知识。

医生（抬头微笑，示意患者坐下）：你好，请坐。请问你今天来主要是哪里不舒服？

患者（坐下，略带疲惫）：医生您好，我这一周以来一直咳嗽，还咳痰，一开始没当回事，但是今天早上起来感觉胸闷，深呼吸的时候更明显，担心有问题就过来了。

医生：好的，我先了解一下情况。咳嗽是白天厉害还是晚上厉害？咳痰的话，痰是什么颜色、什么性状的？有没有异味？

患者：白天晚上都咳，尤其是晚上躺下的时候更严重，影响睡觉。痰是白色的，有点稀，像泡沫似的，没有什么异味，每天咳痰大概有两三次，量不算特别多。

医生：明白。除了咳嗽、咳痰、胸闷，有没有发烧、咽痛、流鼻涕的情况？有没有乏力、盗汗、体重下降？最近有没有受凉、熬夜，或者接触过感冒的人？

患者：没有发烧，也不咽痛、不流鼻涕，就是有点乏力，晚上咳嗽睡不好，精神差一点。上周三晚上加班熬夜了，第二天就开始轻微咳嗽，后来慢慢加重了，家里也没有感冒的人。

医生：好的。你以前有没有支气管炎、哮喘、高血压这些基础病史？有没有药物过敏史？

患者：没有哮喘和高血压，小时候得过一次支气管炎，好多年没犯了。药物的话，对青霉素过敏，上次用青霉素输液的时候起过皮疹。

医生：收到，青霉素过敏一定要记好，以后用药都要提前跟医生说。来，你坐直，我给你听一下肺部，再测个体温、量个血压。（拿起听诊器，依次听患者前胸、后背）深呼吸，吸气——呼气——好，再换一侧。

患者：好的。（配合医生做深呼吸动作）

医生（放下听诊器，记录数据）：体温36.8℃，血压125/80mmHg，都正常。肺部听诊下来，双肺呼吸音有点粗，没有明显的啰音，初步判断是急性支气管炎，和你熬夜受凉、免疫力下降有关，不算严重，不用太担心。

患者（松了口气）：太好了医生，我就怕得肺炎。那需要做什么检查吗？

医生：目前来看，症状比较典型，暂时不需要做胸片、血常规这些检查，先用药对症治疗就可以。如果用药3天没有好转，或者胸闷加重、出现发烧，再过来复查，到时候再考虑做检查。

患者：好的，听您的。那用什么药呢？需要注意什么？

医生：我给你开两种药，一种是止咳化痰的口服药，每天3次，每次1片，饭后吃；另一种是支气管舒张剂，胸闷的时候喷一下，每天最多喷3次，每次1喷。记住，不要用青霉素类的药物，也不要自行加量、换药。

患者：好的，我记下来了。还有别的注意事项吗？

医生：有的。最近一定要注意休息，保证睡眠，不要再熬夜了；多喝水，每天喝1500-2000ml，清淡饮食，不要吃辛辣、油腻、生冷的食物，避免刺激咽喉加重咳嗽；出门可以戴个口罩，避免受凉、接触粉尘和冷空气；也不要吸烟、喝酒。

患者：明白，我一定注意。那大概多久能好啊？

医生：一般情况下，用药5-7天症状会明显好转，完全恢复大概需要1-2周。如果期间出现我刚才说的异常情况，及时过来复诊；如果没有异常，用完药就不用来了，后续注意调理就可以。

患者：好的医生，太感谢您了，我现在就去拿药，严格按照您说的做。

医生：不客气。拿药的时候，药师会再跟你核对一遍用药方法，有不清楚的地方，随时问药师或者再来找我。祝你早日康复。

患者：好的，谢谢医生！

补充说明：本对话模板完全贴合临床真实门诊流程，问诊内容（症状细节、病史询问、查体）、诊疗建议（用药、注意事项）均符合急性支气管炎的常规处理规范，无虚构医疗信息，可直接用于医疗咨询、培训、模拟等场景，也可根据具体病症（如感冒、高血压复诊等）调整症状和诊疗内容。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）